

CONJUNTIVITIS

Andrea Carrancho García, Marta Cuesta Lasso, Ana Garrote Llordén.

INTRODUCCIÓN

La conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la superficie interna de los párpados y la cara anterior de la esclera. Es una estructura muy vascularizada y rica en vasos linfáticos, su principal función es protectora. La conjuntivitis es la inflamación de dicha estructura.

Los síntomas clásicos de una conjuntivitis son **picor, escozor y sensación de cuerpo extraño**. Los signos más comunes son **hiperemia, reacción celular y secreción**. Dependiendo de la etiología, estos signos pueden ser diferentes, constituyendo una ayuda en el diagnóstico y en el manejo terapéutico.

CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS

Conjuntivitis bacteriana aguda

Es una patología común y normalmente autolimitada. Los microorganismos más frecuentemente implicados son *S.pneumoniae*, *S.epidermidis*, *S.aureus*, *M.catarrhalis* y *H.influenzae*. La conjuntivitis por *N.gonorrhoeae* es menos frecuente y más grave.

Diagnóstico

Los signos son variables y dependen de la gravedad de la infección:

- Secreción acuosa inicial que se transforma en mucopurulenta. La secreción purulenta hiperaguda puede indicar infección gonocócica.
- No suele haber adenopatías, excepto en infecciones graves por *N.gonorrhoeae*.
- Edema y eritema palpebral.
- Erosiones epiteliales en córnea.

En los casos graves deben tomarse muestras mediante frotis y raspado conjuntival.

Tratamiento

Antibiótico tópico en pomada o colirio durante 7 días: aminoglucósidos (tobramicina, gentamicina), cada 8 horas, quinolonas (ofloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino), cada 6 horas o macrólidos (eritromicina) generalmente en pomada, una aplicación cada 8 horas.

- Si se sospecha infección por *N.gonorrhoeae* debe instaurarse tratamiento sistémico con ceftriaxona.
- Lubricación ocular.
- Medidas de higiene: limpieza de las secreciones con suero fisiológico, evitar el uso de lentes de contacto al menos 48 horas tras la resolución del cuadro y prevención del contagio.

Conjuntivitis vírica aguda

Es la infección ocular externa más común. Puede ser esporádica o presentarse de forma epidémica y los microorganismos más frecuentemente implicados son los adenovirus y picornavirus. El contagio se produce a través de secreciones respiratorias u oculares, se ve facilitado por la capacidad de las partículas víricas de sobrevivir durante semanas en superficies secas. Habitualmente es un proceso autolimitado que se resuelve espontáneamente pasados 7-20 días.



Reacción folicular e hiperemia conjuntival leves en paciente con conjuntivitis vírica

Diagnóstico

- Edema palpebral.
- Adenopatía preauricular dolorosa.
- Reacción folicular e hiperemia en conjuntiva tarsal.
- Quemosis conjuntival.
- Petequias en conjuntiva tarsal.
- Membranas y pseudomembranas en conjuntiva tarsal.
- Erosiones epiteliales superficiales en córnea.

Tratamiento

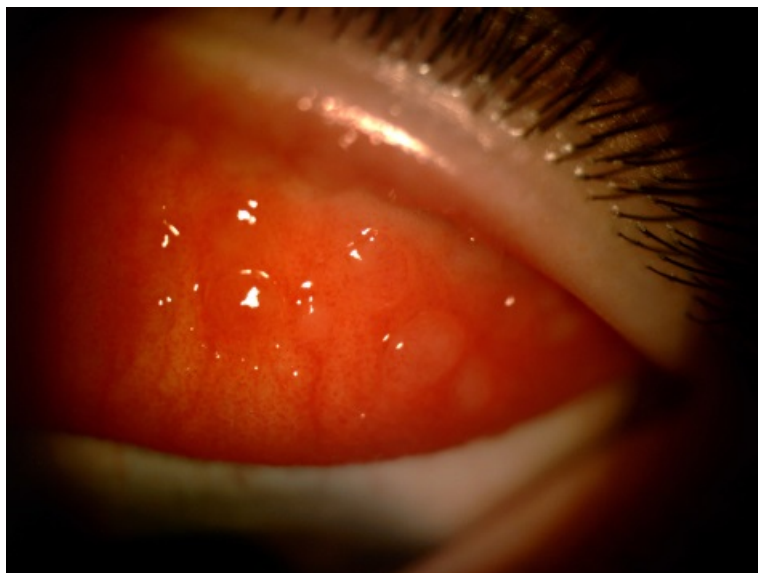
La infección suele resolverse espontáneamente en 2-3 semanas, ningún fármaco específico es necesario. Pasada la infección el paciente puede presentar unos infiltrados subepiteliales corneales con forma numular y distribución difusa que representan una reacción inmunológica frente al virus. Pueden afectar a la visión y persistir meses o años.

- Antibiótico tópico, si se sospecha sobreinfección bacteriana, ofloxacino cada 6 horas 7 días.
- Corticoide tópico: pueden utilizarse en conjuntivitis graves o en aquellas que presenten pseudomembranas, debe utilizarse con cuidado ya que disminuye la inflamación, pero no acelera la curación. Se comienza con una gota cada 6-8 horas dependiendo de la intensidad de la inflamación para reducir la dosis poco a poco.
- Povidona yodada diluida al 5%: reduce el contagio.
- Retirada de las pseudomembranas.
- Lubricación ocular.
- Medidas de higiene: limpieza de las secreciones con suero fisiológico, evitar el uso de lentes de contacto al menos 48 horas tras la resolución del cuadro y prevención del contagio.

CONJUNTIVITIS NO INFECCIOSAS

Conjuntivitis alérgica estacional

Suele ser secundaria a una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos ambientales. Frecuentemente se acompaña de otros síntomas no oftalmológicos y predomina en época estival.



Papilas de gran tamaño en conjuntiva tarsal, paciente con diagnóstico de conjuntivitis papilar gigante

Diagnóstico

Síntomas:

- Picor y lagrimeo.

Signos:

- Quemosis conjuntival.
- Papilas en conjuntiva tarsal (Fig. 2).
- Secreción acuosa.

Tratamiento

- Antihistamínicos tópicos: levocabastina cada 12 horas.
- Estabilizadores del mastocito: cromoglicato sódico 1 gota cada 6-8 horas.
- Fármacos de acción dual tópicos (antihistaminicos y estabilizadores del mastocito): ketonifeno, opatanol, cada 12 horas.
- Lubricación ocular.
- Antiinflamatorios no esteroideos o corticoides tópicos de baja penetrancia, como diclofenaco colirio cada 12 horas o fluorometolona colirio cada 12 horas.
- Valorar tratamiento con antihistamínicos orales si hubiese mala evolución.

Conjuntivitis papilar gigante

Aparece como reacción a un estímulo mecánico repetido sobre la conjuntiva tarsal, en la mayoría de los casos debido al uso de lentes de contacto.

Diagnóstico

Síntomas:

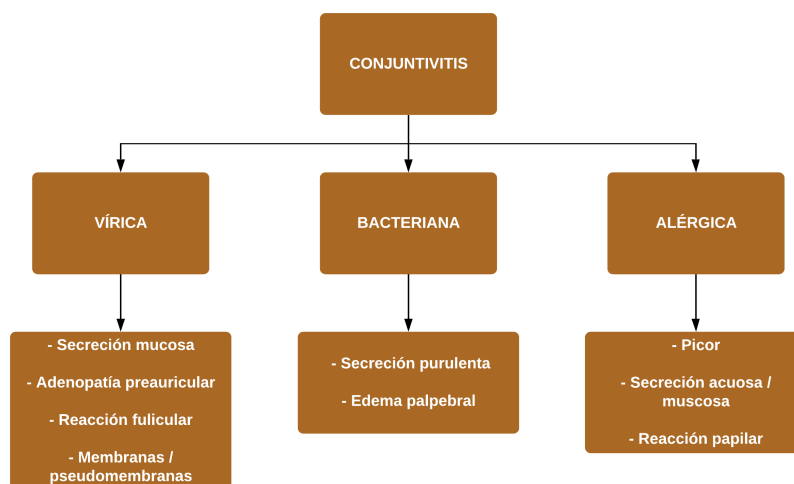
- Sensación de cuerpo extraño.
- Picor.
- Intolerancia a las lentes de contacto.

Signos:

- Secreción mucosa en forma de hebras.
- Hiperemia conjuntiva tarsal.
- Papilas gigantes (>1mm).
- Erosión epitelial superficial en córnea.

Tratamiento

- Interrumpir el uso de lentes de contacto.
- Ketonifeno /Opatanol tópico cada 12 horas.
- Corticoides tópicos de baja penetrancia, fluorometolona cada 8-12 horas dependiendo de la intensidad de la inflamación.



REFERENCIAS

- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. Octava edición, Mosby Barcelona 1996.
- Kovalyuk N et al. Treatment of adenoviral keratoconjunctivitis with a combination of povidone-iodine 1.0% and dexamethasone 0.1% drops: a clinical prospective controlled randomized study. Acta Ophthalmol.2017. Dec; 95(8) 686-e692.
- Gerstenblith AT, Rabinowitz MP. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.